EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 86749
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 16-06-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA MERCEDES RODRIGUEZ GARRIDO			RUN	: 4.509.831-1
F.Nac	: 06-03-1937	Edad	: 87 AÑOS, 3 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: TOMAS YAVAR 554			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 81346238		
Fecha Ingreso	: 2024-06-14	Fecha Egreso	: 16-06-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J10.1-INFLUENZA CON OTRAS MANIFE. RESP., DEBIDAS A VIRUS DE LA IN

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Neumonía por Influenza
Insuficiencia Respiratoria Aguda
Antecedentes de acv hace dos años, secuelado , epoc, hipotiroidismo, hta, icc, ac x fa en taco.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J09-J18-INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina 87 años, con antecedentes de acv hace dos años, secuelado , epoc, hipotiroidismo, hta, icc, ac x fa en taco. En tto con: Concor 2.5 1 al dia, donapezilo 10 mg al dia, aprixaban 2.5mg c/12hrs, disilden 50mg 1/2 al dia, levotiroxina 50 mg al día, atorvastatina 20mg ´por noche, br. de ipatropio 2puff c/12 hrs, espironolactona 25mg dia, budesonida 2 puffc/12hrs, quetiapina 25 mg por noche. Sin alergia conocidas.
es traida por su nuera por compromiso del estdo general mialgia , disnea, desaturacion, ruidos respiratorios audibles.
Ingresa consciente, desorientada en t-e , glasgow 2+5+4=11 pts. hd normotensa, algo taquicardica, subfebril, hiposaturando ambiental. Al ex. físico normocraneo, pirrl, yugulares planas, tórax simétrico, ventila sin apremio, abdomen con resistencia a la palpación, doloroso.
Se realiza exámenes de laboratorio Influenza A : Positivo -Influenza B : Negativo - Virus sincicial : Negativo Proteina C Reactiva : 56,8 Lactato : 1,3 Sodio (Na) : 140,00 mmol Potasio (K) : 3,40 * mmol/L Cloro (Cl) : 98,00 Hemoglobina : 12,4 g/dl Hematocrito : 37,2 o/o Recuento de leucocitos : 11,80 mil/ul Recuento Hematies : 4,26 Mill/ul Plaquetas : 213.
Se hospitaliza por Requerimiento de oxígeno TTO Medico kine .

Durante estancia en servicio de medicina en buenas condiciones generales, eupneica, afebril, con disminución paulatina de requerimiento de oxígeno hasta suspensión, hace más de 24 horas. Soporte KNT con BD.
Cumpliendo terapia ATB

En vista de condiciones se decide derivar a HODOM para continuidad de atención.

INDICACIONES AL ALTA

1. Ceftriaxona 2 Gr Dia Ev (3/7)
2. Oseltamivir 75mg 1 C 12hrs Vo (5 días)
3. Apixaban 2,5 Mg, 1 Comprimido Cada 12 Horas, Vía Oral.
4. Atorvastatina 40 Mg, 1 Comprimido Por Noche, Vía Oral.

5. Omeprazol 20 Mg, 1 Cápsula Al Día, Vía Oral.
6. Bisoprolol 2,5 Mg, 1 Comprimido Al Día, Vía Oral.
7. Losartan 50 Mg, 1 Comprimido Cada 12 Horas, Vía Oral.
8. Amlodipino 10 Mg, 1 Comprimido Al Día, Vía Oral.
9. Hidralazina 50 Mg, 1 Comprimido Cada 8 Horas, Vía Oral.
10. Amiodarona 200 Mg, 1 Comprimido Al Día, Vía Oral.
11. Sertralina 50 Mg, 1 Comprimido Al Día, Posterior A Desayuno.
12. Fluticasona/Salmeterol, 2 Puff Cada 12 Horas, Con Aerocámara
13. Bromuro Ipratropio, 4 Puff Cada 8 Horas Y Sos, Con Aerocámara.
14. Salbutamol 4 Puff Cada 6 Horas
15. KNTR interdiario

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO